

ชื่อกิจกรรม “การออกข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination: OSCE”

ครั้งที่ 2/2564

อาจารย์ ดร.ณัฐมา ทองธีรธรรม วิทยาการ
ผู้ช่วยอาจารย์ภิญญาพัชญ์ กิตติธัญญ์ธรรมา ผู้ลิขิต

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การออกข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination: OSCE โดยอาจารย์ ดร.ณัฐมา ทองธีรธรรม ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 704 คณะพยาบาลศาสตร์ (บางกอกน้อย) และผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team รายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- แนวทางการออกข้อสอบ OSCE
- การเตรียมการจัดสอบและการบริหารการสอบ OSCE
- แนวทางในการดำเนินการเพื่อเตรียมการจัดสอบ OSCE

แนวทางการออกข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination: OSCE

- กำหนดวัตถุประสงค์ของการออกข้อสอบให้ชัดเจน โดยส่วนใหญ่จะใช้เพื่อประเมินในส่วนที่สามารถประเมินได้ยาก เช่น
 - การประเมินปัญหาของผู้ป่วย
 - การสื่อสารกับผู้ป่วย การซักประวัติและการให้คำแนะนำ
 - ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สื่อสารระหว่างทีมการดูแล
 - การปฏิบัติการพยาบาล
 - จริยธรรมในเชิงวิชาชีพ
- มีกรรมการในการจัดทำ test blueprint
- ข้อสอบในแต่ละหน่วยไม่จำเป็นต้องออกข้อสอบครบทุกทักษะ
- ตรวจสอบข้อสอบที่แต่ละหน่วยออกมาว่าตรงกับ test blueprint หรือไม่
- วิเคราะห์ ตรวจสอบและปรับปรุง test blueprint ใหม่ทุกครั้งหลังจากการจัดสอบ

ลักษณะข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination: OSCE

- สถานการณ์ (Scenario) ควรต้องใช้ข้อมูลผู้ป่วยจริง จะทำให้สถานการณ์นั้นเหมือนจริงมากขึ้น โดยครอบคลุม
 - หัวเรื่องของข้อสอบ
 - วัตถุประสงค์ และเวลาที่ใช้ในการสอบ
 - ผู้สอบและอาจารย์ผู้คุมสอบ

- สถานการณ์/ประวัติและผลการตรวจร่างกาย
- รายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้
- ลักษณะผู้ป่วยมาตรฐาน (ถ้าต้องใช้)
- คำแนะนำผู้เข้าสอบ (Instruction for examination) จะต้องมีความสั้นกระชับและมีความชัดเจน เนื่องจากผู้เรียนจะมีความตื่นตันท่าทำให้เข้าใจผิดพลาดได้ง่าย
- คำแนะนำผู้ป่วยมาตรฐาน (Standardized patient: SP)
- เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubric) ที่ชัดเจนตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด
- คำแนะนำสำหรับอาจารย์ผู้คุมสอบ ไม่ควรมีการตั้งคำถามในระหว่างที่ทำการสอบ กระตุ้นผู้เรียนได้บ้างแต่ไม่บอกใบ้ในสถานการณ์นั้นๆ ที่ทำการประเมิน
- วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้คุมสอบทราบว่าต้องการประเมินทักษะใดของผู้สอบ
- ผู้สอบ ต้องมีการกำหนดผู้สอบเนื่องจากระดับความยากง่ายที่มีความแตกต่างกัน
- คำสั่ง ต้องสั้นกระชับ ผู้สอบอ่านแล้วเข้าใจง่าย
- เวลา ต้องมีการระบุเวลาเพื่อให้ผู้ที่ดำเนินการสอบสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาได้อย่างดี และมีความเหมาะสม (ไม่ควรเกิน 30 นาที)
- รายการอุปกรณ์ ต้องมีการระบุรายละเอียด ทั้งจำนวนและลักษณะเฉพาะเพื่อสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบได้อย่างถูกต้อง

หลักการให้คะแนนการประเมินด้วยวิธีการใช้ Objective Structured Clinical Examination: OSCE

- การให้คะแนนอาจเลือกใช้ 2 วิธีการ
 1. Rubric scale ซึ่งไม่มีหลักฐานทางวิชาการว่าแบบไหนตรงมากกว่ากัน ได้แก่
 - Checklist ลักษณะของการประเมิน “ทำ” หรือ “ไม่ทำ”
 - Rating scale ลักษณะของการประเมิน “ไม่ทำ” “ทำไม่ถูกขั้นตอน” หรือ “ทำถูกขั้นตอน” ต้องกำหนดเกณฑ์ตัดสินให้ชัดเจน
 2. สะท้อนกลับ (Feedback) ภายหลังจากการสอบ อาจารย์ที่คุมสอบจะต้องบอกจุดดี จุดด้อยของผู้ถูกสอบเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาของผู้เรียน ควรต้องทำภายหลังสอบสิ้นสุดทุกข้อเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากส่งผลกระทบในเวลาสอบ
- จำเป็นต้องมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการสอบ “ผ่าน” หรือหากไม่ปฏิบัติในข้อใดถือว่า “สอบตก”
- แบบประเมินต้องมีความครบถ้วน ไม่ละเอียดมากจนเกินไป และไม่ควรรยาวมากเกินไป เนื่องจากจะทำให้ผู้คุมสอบให้ความสำคัญกับแบบประเมินมากกว่าการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าสอบ

- คะแนนในทุกข้อของการสอบจะต้องมีคะแนนรวมเท่ากัน
- ต้องให้ความสำคัญกับลำดับของขั้นตอนการปฏิบัติ
- การประเมินมุ่งเน้นการประเมินพฤติกรรมของผู้เข้าสอบ โดยเฉพาะจุดที่ผู้เข้าสอบมักทำผิดหรือเข้าใจผิดได้ง่าย
- แบบประเมินจะต้องสื่อความหมายที่ตรงกัน ดังนั้นอาจต้องมีคำอธิบายการใช้แบบประเมินแนบท้าย

หลักการในการพิจารณาข้อสอบและแบบประเมินผล

- ระยะเวลาเหมาะสมหรือไม่
- ระดับความยากเหมาะสมหรือไม่
- เครื่องมือ/อุปกรณ์เหมาะสมหรือไม่
- คำอธิบายมีความชัดเจนหรือไม่

การเตรียมการเพื่อจัดสอบ Objective Structured Clinical Examination: OSCE

- มีการจัดประชุมทีมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเตรียมการจัดการสอบ
 - ผู้ดูแลอาจารย์ประเมินผลการสอบ
 - ผู้ดูแลผู้ป่วยมาตรฐาน
 - ผู้ดูแลโจทย์ข้อสอบและการประเมิน
 - ผู้จัดเตรียมอุปกรณ์/สถานที่
- การจัดทำผังข้อสอบ โดยพิจารณาดังนี้
 - ขนาดของห้องสอบเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ใช้สอบ
 - ระมัดระวังเรื่องเสียงที่จะรบกวนกันในการสอบแต่ละฐาน และการมองเห็นข้อสอบในฐานต่อไปของผู้เข้าสอบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของผู้สอบ
 - ต้องมีฐานพักสำหรับกรณีที่ผู้เข้าสอบได้เข้าสอบในฐานก่อนหน้าที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
- ผังผู้เข้าสอบ โดยกำหนดวง และจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละวง การเคลื่อนตัวของผู้สอบในแต่ละวงและเวลาในแต่ละฐาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์	อุทธิยะประสิทธิ์	ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลดา	ฉันทน์เรืองวนิชย์	ประธาน
3. อาจารย์ ดร.ณัฐมา	ทองธีรธรรม	วิทยากร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรางทิพย์	นายพทุธ	
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี	ศรีมรกต	
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี	อัศดรวิเศษ	
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร	วาณิชกุล	
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชต	วงרות	
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อผกา	สุทธิพงษ์	
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรารวรรณ	เชื้อตาเล็ง	
11. อาจารย์ดร.สุชาดา	ภัทรมงคลฤทธิ์	
12. อาจารย์ ดร.รัตติมา	ศิริโหราชัย	
13. อาจารย์ ดร.ณัฐมา	ทองธีรธรรม	
14. อาจารย์ ดร.ฐิติพงษ์	ต้นคำปวน	
15. อาจารย์ศัทธินิยา	คงเพชร	
16. อาจารย์ปิยาภรณ์	เยาวเรศ	
17. อาจารย์สกุลรัตน์	เตียววานิช	
18. อาจารย์พรสินี	เต็งพานิชกุล	
19. อาจารย์พัชรี	เสนห์เจริญ	
20. ผู้ช่วยอาจารย์ยุทธพิชัย	โพธิ์ศรี	
21. นางสาวกนกทิพย์	บุญเจริญ	
22. ผู้ช่วยอาจารย์ภิญญาพัชญ์	กิตติธัญญ์ธีรกุล	เลขานุการ

สรุปผลการนำความรู้ไปใช้ของแต่ละกิจกรรม

ด้านการดำเนินงาน			อธิบายการนำไปใช้ประโยชน์/ ประโยกต์ใช้
ศึกษา ✓	วิจัย	อื่นๆ	1. ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination: OSCE และปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การออกแบบข้อสอบ OSCE เป็นไปตามมาตรฐาน 2. ได้ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบข้อสอบ OSCE เพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลทักษะปฏิบัติของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติจริงและปฏิบัติการพยาบาลเป็นมาตรฐานเดียวกัน 3. อาจารย์ในภาควิชาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การออกแบบข้อสอบ OSCE และได้มีการวาง แนวทางในการดำเนินการ เพื่อเตรียมการจัดสอบ OSCE ของภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ดังนี้ - จัดทำพิมพ์เขียวข้อสอบ (Test blueprint) - ออกข้อสอบและแบบประเมินการสอบแต่ละข้อ - วิพากษ์และปรับปรุงข้อสอบ OSCE - จัดเตรียมรายการอุปกรณ์สำหรับการจัดสอบ - ประชุมทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมการสอบ - สรุปผลการสอบ